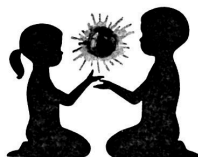


ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1
Тел.: (495) 287-65-70



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное учреждение
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА»**
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России)

29.04.2026

№ 11

Москва

ПРОТОКОЛ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
заседания врачебной подкомиссии
от 29.04.2026
(Приказ от 27.12.2019г. № 247/19)

Врачебная подкомиссия ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России в составе (ФИО, должность):
Председатель подкомиссии - Д.В. Литвинов - главный врач

Члены подкомиссии:

1. А.В. Пшонкин - заведующий отделением - врач-детский онколог (стационар кратковременного лечения)
2. А.Е. Сысоев - врач-детский онколог (отделение нейронкологии)
3. Ю.А. Родина - заведующий отделением - врач-аллерголог-иммунолог (отделение иммунологии)
4. Л.Н. Шелихова - заведующий отделением - врач-гематолог (отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток №1)

Повестка заседания врачебной подкомиссии: о признании пациента инкурабельным, о необходимости оказания паллиативной помощи.

Ф.И.О. пациента: БАРАХТЕНКО ЕГОР АНДРЕЕВИЧ

Дата рождения: 24.04.2008

Возраст: 18 л.

Пол: Мужской

Адрес постоянного места жительства: Российская Федерация, Саха /Якутия/ Респ., г. Якутск, III Сергеляхское 5 км д. 45 кв. 5А

Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 98 22 номер 005881 дата выдачи 16.06.2022 выдан 140-002 МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Медицинский страховой полис 1495199725000160 дата выдачи 10.03.2015

Диагнозы:

Основное: Миелодиспластический синдром с гиперэкспрессией WT1, мутация в гене NRAS от 21.11.24; первая алло-ТГСК (ПСКК) от неродственного HLA-идентичного донора от 01.04.25; первая клинико-гематологическая, молекулярная ремиссия от 29.04.25. Вторичный миелоидный лейкоз в исходе миелодиспластического синдрома от 03.07.25, внутреннее тандемное удвоение в гене FLT3 (FLT3/ITD), гиперэкспрессия гена WT1, BAALC; повторная алло-ТГСК от гаплоидентичного донора (отец) от 16.09.25; клинико-гематологическая, молекулярная ремиссия от 14.10.25; молекулярный рецидив (FLT3/ITD, гиперэкспрессия гена WT1, BAALC-39) от 13.11.25, персистенция МОБ (ИФТ) от 04.12.25; инфузия донорских лимфоцитов №1 (1,0x10⁵) от 08.12.25; костно-мозговой рецидив от 15.01.26. Введение анти CD33 CAR-NK лимфоцитов от 8.04.2026 от гаплоидентичного донора (отца). Прогрессия от 23.04.2026. (С92.0 Острый миелобластный лейкоз [ОМЛ])

Сопутствующее: Аорто-мезентериальный конфликт слева (сдавление левой почечной вены). (N28.8 Другие уточненные болезни почек и мочеточника)

Осложнение основного: Индуцированная аплазия кроветворения (D70 Агранулоцитоз)

Осложнение основного: Реципиент ТГСК (D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения)

Осложнение основного: Реципиент ТГСК (Z94.8 Наличие других трансплантированных органов и тканей)

На основании данных консилиума, проведенного 29.04.2026 у пациента с острым миелобластным лейкозом на + 14 сутки после CAR-T клеточной терапии по данным проведенного контрольного обследования (КМП от 23.04.26) в миелограмме содержание бластных клеток с морфологическими чертами миелоидной линии дифференцировки составляет 71,0% и 60,0% по точкам соответственно, MRD методом проточной цитометрии: опухолевая популяция 51,2 %, экспрессия CD33+ на 100% бластных клеток, персистенция анти- CD33 CAR-NK лимфоцитов: в КМ 35.2% от NK-клеток, в периферической крови 40.4% от NK- клеток. Принимая во внимание объем проведенного лечения (химиотерапевтического, двух аллогенных ТГСК и CAR-T клеточной терапии), тяжелый соматический статус пациента и рефрактерность к проводимой комплексной терапии все куративные опции в настоящий момент исчерпаны. В связи с отсутствием альтернативных методов лечения, состояние ребенка признано инкурабельным. Дальнейшая терапия может носить исключительно симптоматический характер, поддерживая жизнь и облегчая страдания больного. С законным представителем (Отец пациента) проведена беседа о крайне неблагоприятном прогнозе.

В качестве паллиативной терапии решено провести:

1. Сдерживающую терапию: преднизолон 10 мг 2 р/сут р.о.. При нарастании гепатоспленомегалии, лейкоцитоза в периферической крови рассмотреть вопрос о проведении курсов цитарабина 200 мг/м², вепезида 200 мг/м² или циклофосфида 150 мг/м² на фоне приема аллопуринола 300 мг/сут и инфузионной терапии.
2. Симптоматическую терапию с целью купирования отягчающих симптомов, в том числе обезболивание по требованию, включая применение наркотических анальгетиков при необходимости

Выводы подкомиссии:

1. Учитывая полученные результаты исследований у ребёнка имеет место прогрессия заболевания. Пациент признан инкурабельным.
2. Рекомендовано оказание ребенку паллиативной медицинской помощи в медицинской организации по месту жительства .

Председатель подкомиссии

подпись

/ Д.В. Литвинов

Члены подкомиссии

подпись

В.В. Пшонкин

подпись

А.А. Сысоев

подпись

Ю.А. Ролина

подпись

Л.Н. Шелихова